

10. FORMACIÓN DEL INTESTINO SUPERIOR

DURACIÓN : 25:32

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora en profundidad el desarrollo del intestino superior, destacando los complejos movimientos del endodermo y las interacciones vasculares. Aprenderá cómo estos procesos embriológicos se traducen en la formación de los arcos branquiales y la organización de las estructuras faciales, y cómo este conocimiento puede aplicarse en un contexto terapéutico. Se abordan los conceptos de flexión embrionaria, cerebralización y el impacto de la osteopatía en la dinámica de los arcos mandibulares y las estructuras dentales, ofreciendo así herramientas prácticas para restaurar la armonía frente a la arquitectura interna.

FORMACIÓN DEL INTESTINO SUPERIOR

La formación del intestino superior es un proceso complejo que implica el movimiento del **endodermo**. Este movimiento se manifiesta tanto en su globalidad como de manera **transversal**, transformando un saco en un tubo. La **cavidad amniótica** juega un papel clave en este movimiento, englobando completamente el embrión e integrando el tubo digestivo de afuera hacia adentro, principalmente orientado por el **freno aórtico** primitivo.

Centrándonos en el plano **vascular**, se observa que los tubos endocárdicos primitivos se aproximan simultáneamente al cierre del tubo neural. Este encuentro crea un espacio en la luz del **endodermo vitelino primitivo**, formando lo que se conoce como el **intestino faríngeo**. Este proceso se desarrolla en la línea media, mientras que lateralmente, aparece la **celulosa**.

El crecimiento diferencial del **tejido epitelial** con respecto al **tejido conjuntivo** permite la aproximación de las dos aortas en el eje central, delimitando así el eje longitudinal y creando el intestino faríngeo. El intestino superior se extiende desde la boca hasta la parte media, implicando la formación de la cara.

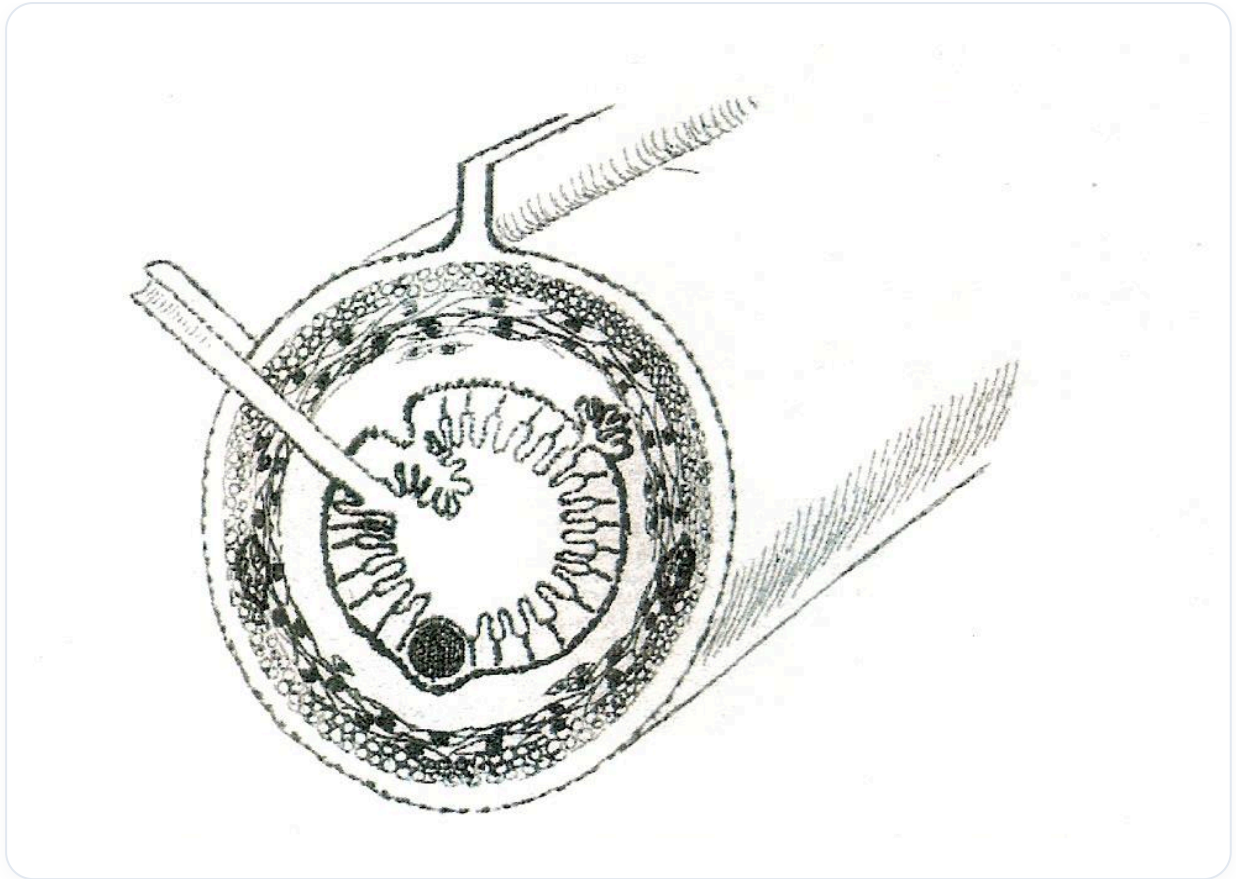


FIG. — Corte transversal intestino

Aproximadamente a los quince días, al final de la segunda semana, el embrión puede dividirse en tres partes: el **tercio superior**, el **tercio medio** y el **tercio inferior**. La cabeza del futuro embrión es desproporcionada en comparación con un tronco pequeño, siendo la parte cefálica ya identificable. La mitad del embrión se encuentra en la base del cráneo, en relación con el **campo notocordal** con respecto a la línea primitiva.

La flexión del embrión está influenciada por el sistema vascular. Un esquema simple muestra que un tubo se pliega, con una zona que se densifica y otra que se estira, formando así **plicaturas**. En el interior, el tejido es **endodérmico**, mientras que en el exterior es **ectodérmico**, con un tejido **mesodérmico** entre ambos. Los arcos branquiales, organizados en el espacio con respecto al embrión, contienen información específica.

Cada arco branquial está orientado hacia la base del cráneo. Los arcos mandibulares, por ejemplo, se unen hacia esta base. Tratar una cara o un cráneo implica restaurar esta función primitiva, restableciendo un **campo energético** que se organiza hacia este espacio.

Se pueden identificar cuatro grandes arcos branquiales funcionales: el **arco mandibular**, el **arco hioideo**, el **arco laríngeo superior** y el **arco laríngeo inferior**. Cada arco, ya sea ectodérmico, mesodérmico o endodérmico, contiene una información específica. El arco mandibular, por ejemplo, está relacionado con el cartílago mandibular y con estructuras del **oído interno**. Una desestabilización de la mandíbula puede, por lo tanto, afectar la organización interna del oído.

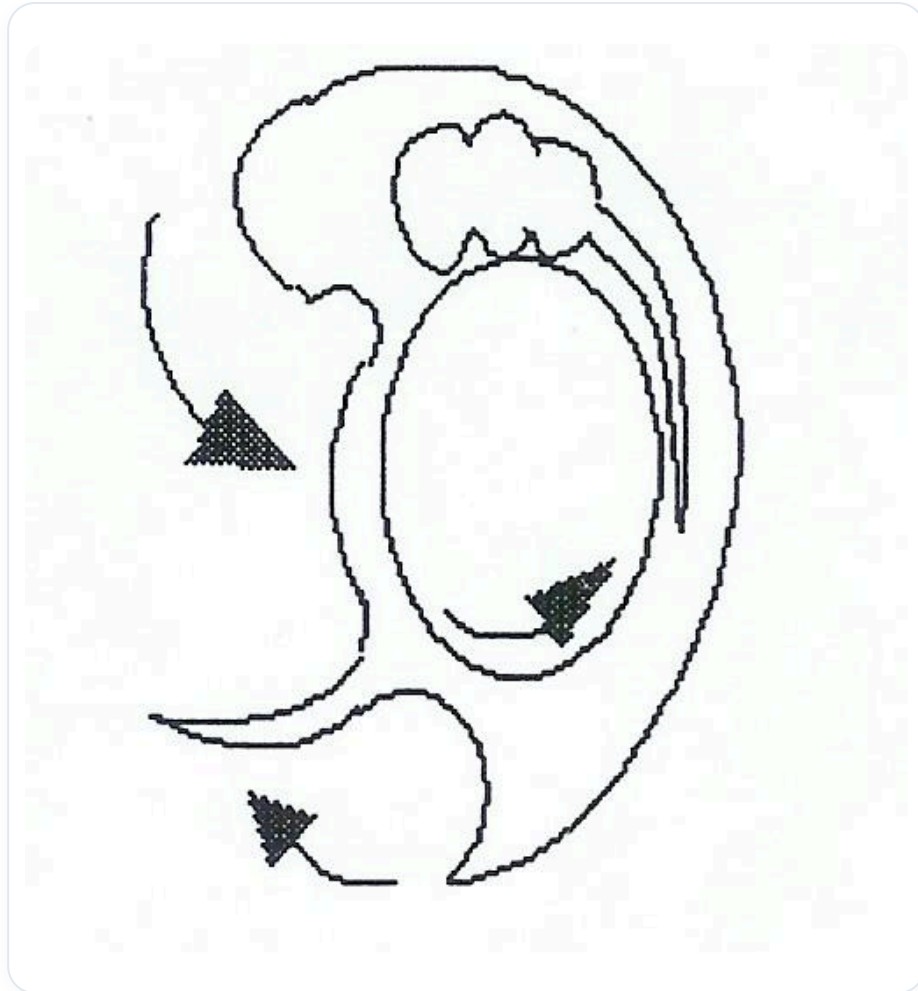


FIG. — Oído interno embrionario

El proceso de flexión y alargamiento del embrión también está relacionado con la **cerebralización** y la formación del **sistema prosencefálico**. Este desarrollo se produce en un proceso **biodinámico**, donde el embrión comienza a plegarse y a abrirse. El corazón se desarrolla entre la mente, el tubo neural y el hígado, creando así la cara.

La ruptura de la **membrana bucofaríngea** marca el inicio de la formación de la boca, que se desarrolla horizontalmente debido a la compresión entre el corazón y el cerebro. Esta compresión integra el tejido mesodérmico, que contiene la información vascular. La aparición del **nasal pit** y de la cavidad oral también está relacionada con esta dinámica.

El desarrollo del cerebro está relacionado con el proceso de **telencefalización**, que implica una ascensión del cerebro y un descenso visceral. La cara, al principio, es un campo de compresión entre el corazón y el cerebro, y por el crecimiento del embrión, se abre.

El desarrollo de los **pterigoides** y del **paladar** está influenciado por la tracción del cerebro y el descenso visceral. Este movimiento sincronizado entre el sistema digestivo y el corazón, así como la ascensión cerebral, contribuye a la formación del paladar ojival.

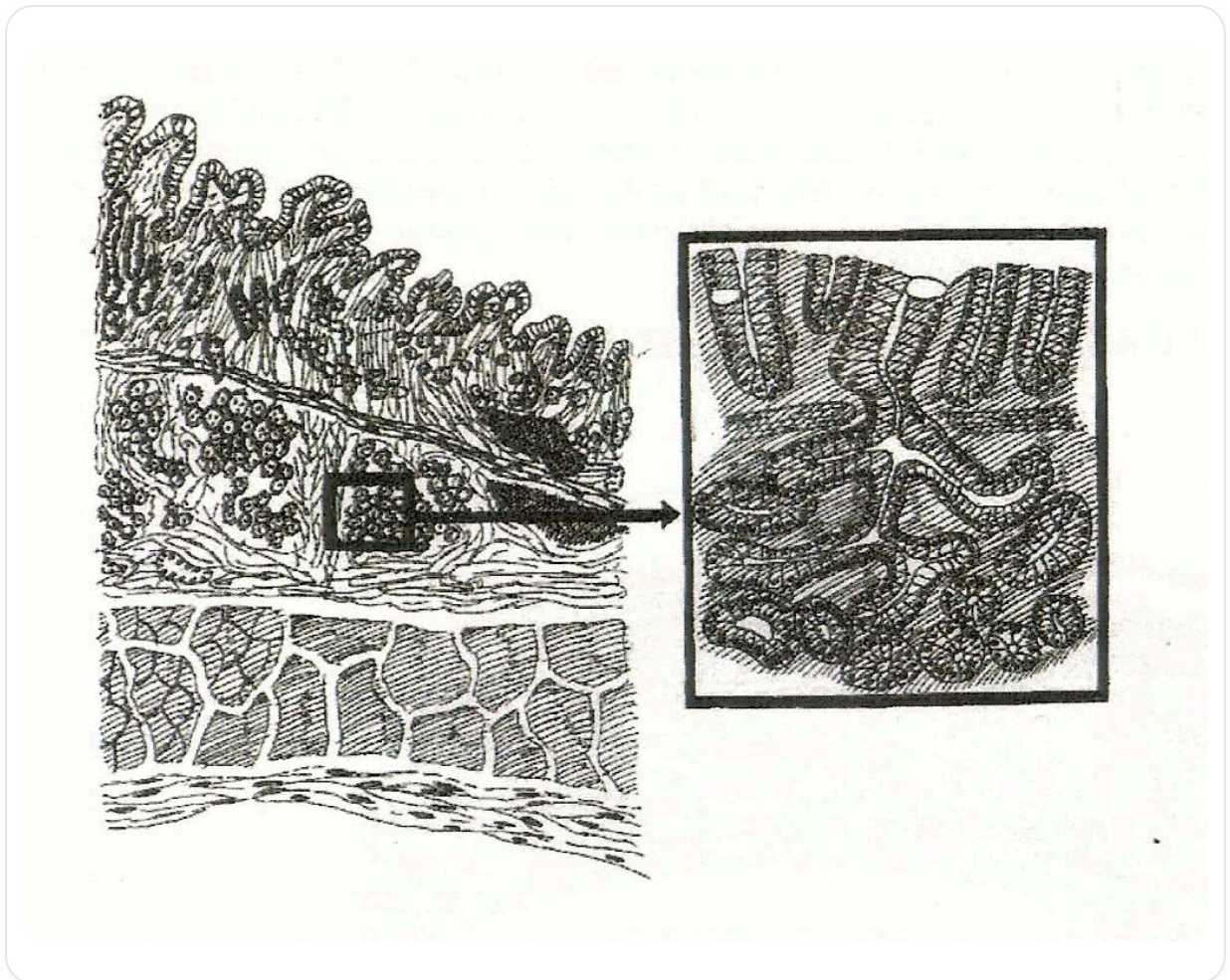


FIG. — *Vellosidades del tejido intestinal*

Las fuerzas oclusales, las presiones del macizo lingual y los efectos piezoeléctricos también influyen en la formación de los dientes y las estructuras faciales. Cada diente recibe una información específica, y tratar la cara o los dientes requiere reequilibrar estas estructuras con su origen embrionario.

En conclusión, la formación del intestino superior y de las estructuras faciales es un proceso complejo, que implica interacciones dinámicas entre los diferentes tejidos embrionarios y su desarrollo sincronizado.

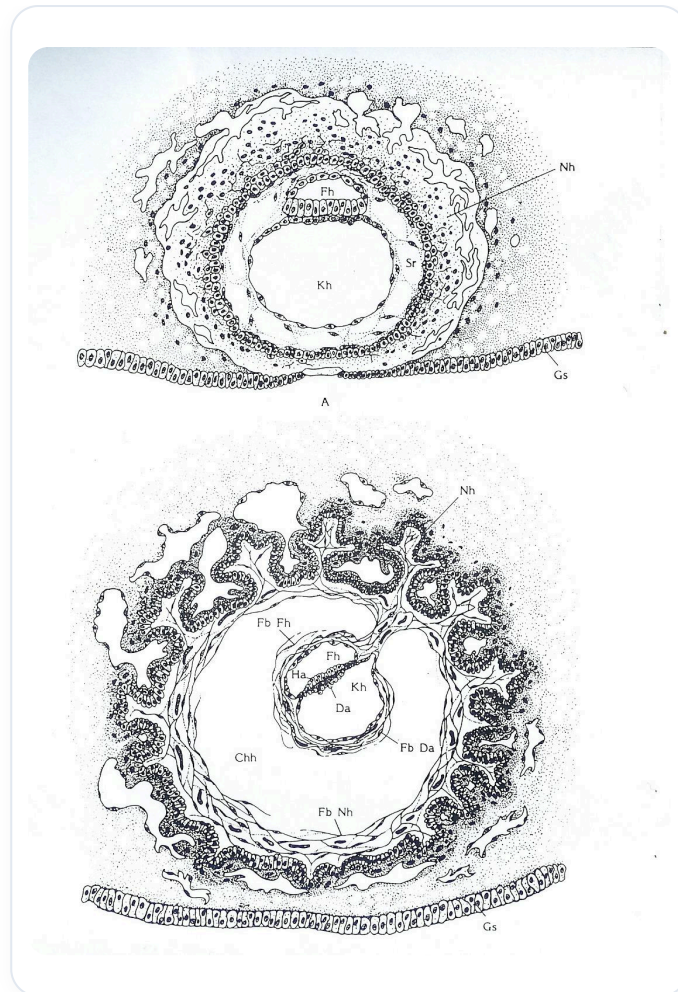


FIG. — Desarrollo embrionario de aves

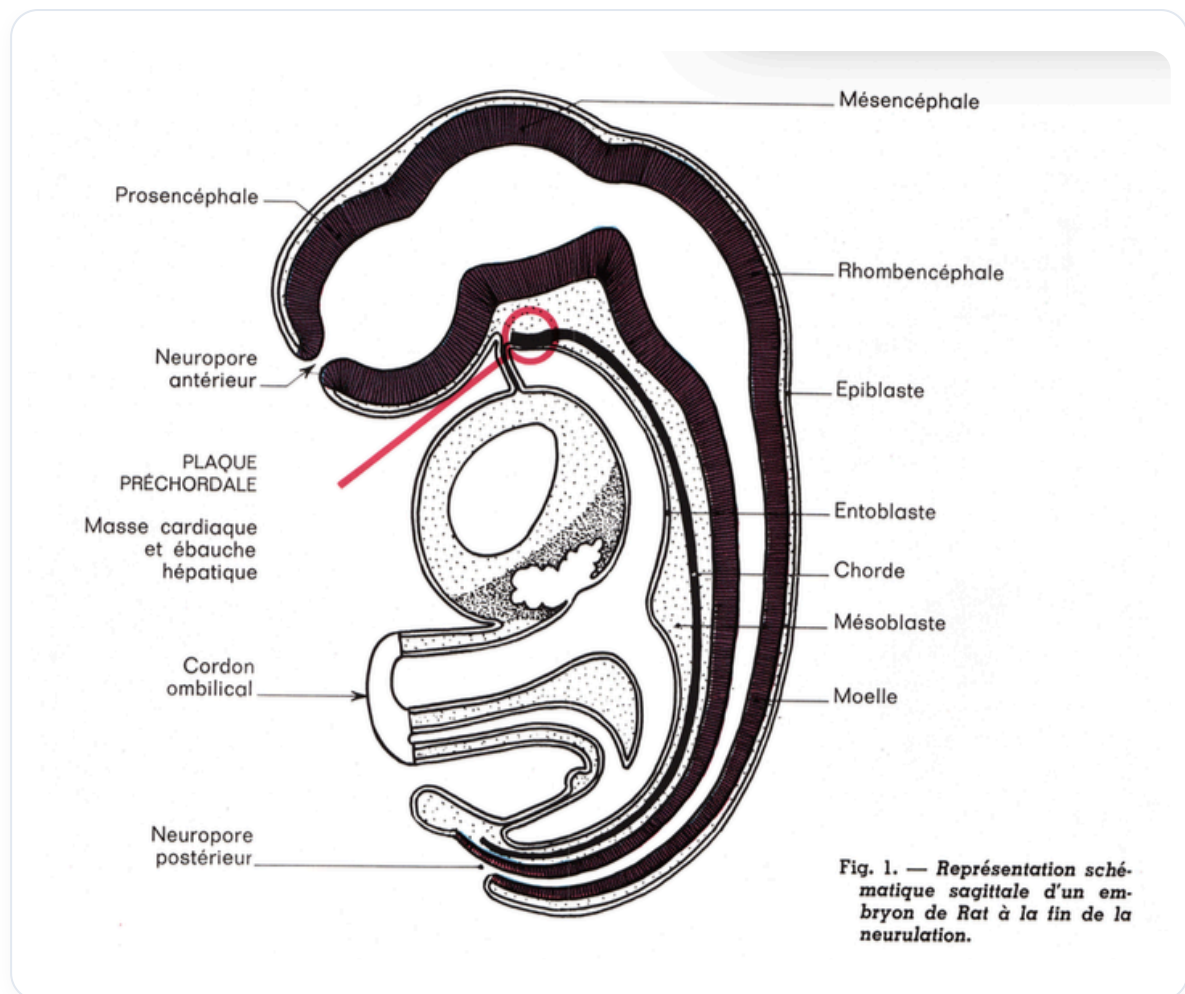


FIG. — Neurulación del embrión de rata

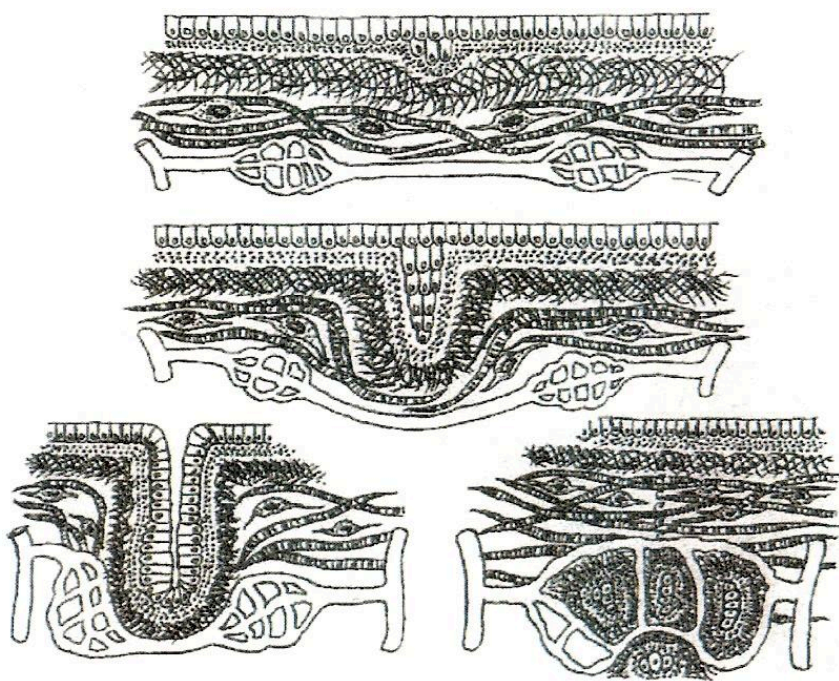


FIG. — Villificación intestinal